

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



«Ο έξυπνος άνθρωπος επιλύει ένα πρόβλημα.
Ο σοφός άνθρωπος το αποφεύγει».

Albert Einstein, 1879-1955.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Γενικά: Οξεία Αιμορραγία από το Ανώτερο Πεπτικό (ΑΑΠ) είναι κάθε αιμορραγία από τον οισοφάγο, το στομάχο ή το 12δάκτυλο μέχρι το σύνδεσμο του Treitz. Η ΑΑΠ μπορεί να παρουσιαστεί ως **αιματέμεση** σε ποσοστό (25%), ως **μέλαινα** κένωση στο ίδιο ποσοστό για την εμφάνιση όμως της οποίας απαιτείται απώλεια 100-200 ml αίματος στα κόπρανα και ως **αιματοχεσία** (15%) η οποία παρατηρείται συχνότερα σε μαζικές αιμορραγίες.

Η εκτίμηση των χαρακτήρων της αιμορραγίας (χρώμα, σύσταση και ποσότητα αίματος) έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στην εστία, στον ρυθμό απώλειας αίματος (βαρύτητα), αλλά και εάν είναι πρόσφατη ή όχι.

Οι ΑΑΠ αποτελούν το 80-90% των αιμορραγιών του γαστρεντερικού συστήματος. Συνήθως, ένα ποσοστό 70-80% των αιμορραγιών αυτών αυτοπεριορίζεται τα δύο πρώτα 24ωρα, ενώ η θνητότητα παραμένει σταθερά περίπου στο 10%. Οι βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες είναι: η ηλικία > 60 ετών, η εικόνα shock κατά την εισαγωγή ($HR > 100/\text{λεπτό}$ και $\Sigma ΑΠ < 100 \text{ mmHg}$), καθώς και η παρουσία σοβαρών, χρόνιων ή ανιάτων νοσημάτων.

Ιστορικό: Ερευνούμε την ύπαρξη ιστορικού παλαιότερων επεισοδίων αιμορραγίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν ο ασθενής πάσχει από χρόνια νόσημα (νεόπλασμα, κίρρωση), ή αν λαμβάνει φάρμακα και ειδικά ασπιρίνη, αντιπηκτικά (*Sintrom/NOACs*), ΜΣΑΦ ή αν έχουν προηγηθεί θεραπευτικές παρεμβάσεις ή αν σημειώνεται πρόσφατη απώλεια βάρους.

Κλινική εικόνα: Ερευνούμε τη σημειολογία και το χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων της ΑΑΠ· επίσης την εντόπιση, την επέκταση και τον χαρακτήρα του πόνου. Αξιολογούμε τις περιγραφές του ασθενούς για καφεοειδείς εμέτους, αιματέμεση, μέλαινα ή αιματοχεσία.

Ο ασθενής συνήθως προσέρχεται στο ΤΕΠ με έντονη ωχρότητα δέρματος, προσώπου ή επιπεφυκότων. Επίσης, παρατηρείται εφίδρωση, υπόταση, ταχυσφυγμία, ταχύπνοια, ψυχρά άκρα, ξηρότητα στόματος (δίψα), ανησυχία, διέγερση, σύγχυση, λήθαργος, κ.λπ.

Ελέγχουμε ζωτικά σημεία ($ΑΠ$, HR , RR , SpO_2 , $\theta^\circ C$), ΗΚΓ, Hct/Hb. Δίνουμε περισσότερη σημασία στις μεταβολές (π.χ: αύξηση) του καρδιακού ρυθμού, ενώ ο έλεγχος των Hct/Hb δεν θεωρείται αξιόπιστος οδηγός, ιδίως κατά τις πρώτες ώρες. (*Προσοχή απαιτείται όταν ο ασθενής λαμβάνει χρονίως β-αποκλειστές ή ιβαμπραδίνη, οπότε οι σφυγμοί του πιθανώς να παραμένουν χαμηλοί ακόμα και σε περιπτώσεις θρόας αιμορραγίας του πεπτικού*).

Αιτίες & διαφορική διάγνωση της ΑΑΠ: Αιμορραγική γαστρίτιδα με οξύ έλκος (20%), 12δακτυλικό έλκος (25%), ρήξη κιστών οισοφάγου (15%), σύνδρομο Mallory - Weiss (5%), νεοπλάσματα (15%), αγγειοδυσπλασίες, συρίγγια επικοινωνίας με αγγεία κ.ά. Έτσι, έντονος εργώδης έμετος και πόνος στον θώρακα ή στο επιγάστριο πριν την αιμορραγία, υποδηλώνει πιθανώς σύνδρομο Mallory - Weiss, που θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από το σύνδρομο Boerhaave που περιλαμβάνει ρήξη του οισοφάγου και αιμορραγία (βλ. *τριάδα Mackler*).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Εξασφαλίζουμε ανοιχτό αεραγωγό, απομακρύνοντας πύγματα αίματος ή εμέσματα (Α).
2. Χορηγούμε O_2 στα 4-8 lt/min (*με προσωπίδα ή με μάσκα Venturi*) και παρακολουθούμε συνεχώς τον κορεσμό O_2 (SpO_2) με παλμικό οξύμετρο στα δάκτυλα ή στο αφτί (Β).
3. Εκτελούμε ΗΚΓ και παρακολουθούμε συνεχώς την ΑΠ και τον καρδιακό ρυθμό (C).
4. Ο ασθενής υποβάλλεται πάντοτε σε δακτυλική εξέταση, για έλεγχο αίματος ή μέλαινας.
5. Τοποθετούμε ευρεία (#16-18G) 3way φλεβική γραμμή και χορηγούμε 1 lt NaCl 0,9% ή 1 lt R/L ή R/S. Επί εξεσημασμένης υπότασης ($\Sigma ΑΠ < 90 \text{ mmHg}$) ή επί μη ανταπόκρισης στη χορήγηση υγρών, τότε παράλληλα με τα **κρυσταλλοειδή** διαλύματα χορηγούνται και 500-1000 ml κολλοειδούς διαλύματος Voluven 6% (ή Haemacel). Χορηγούνται επίσης, 1-2 amp. **Σιμετιδίνη** (Tagamet 200 mg) και 1 amp. **PPI** (Lordin) ως δόση εφόδου (iv).
6. Σε βάσιμη υποψία γαστρορραγίας, τοποθετούμε **ρινογαστρικό καθετήρα Levin** (διπλού αυλού αν υπάρχει), αναρροφούμε και ξεπλένουμε ήπια, με παγωμένο φυσιολογικό ορό.

Η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα Levin κρίνεται απαραίτητη, αφού δεν αποσκοπεί μόνον στην εκτίμηση της δραστηριότητας της αιμορραγίας, αλλά επιβεβαιώνει ή όχι, τη διάγνωση της οξείας αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού *per se*.

7. Τοποθετούμε σε ορό 5 amp. **PPI** (Nexium / Zureazol), σε βραδεία έγχυση (8-10 mg/h). Οι υψηλές αρχικές δόσεις PPI είναι απαραίτητες, διότι αμβλύνουν το όξινο γαστρικό pH (στόχος pH ≥ 6), συμβάλλοντας έτσι στην ακεραιότητα του τοιχωματικού θρόμβου.
8. Σε 100 ml N/S τοποθετούμε **Μετοκλοπραμίδη** (1 amp. Primperan 10 mg), για ευόδωση της γαστρικής κένωσης και διευκόλυνση της ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού.
9. Αν η αιμορραγία είναι αθρόα και ο ασθενής ασταθής, τοποθετούμε 2^η φλεβική γραμμή και σε ορό 100 ml N/S τοποθετούμε **Σωματοστατίνη** (1 amp. Stilamin 0,25 mg/amp.) σε ταχεία ενδοφλέβια έγχυση, εντός 3-5 λεπτών. Έπειτα, χορηγούμε 1000 ml NaCl 0,9%, με 1 amp. Stilamin (των 3 mg/amp.) σε διάστημα 8 ωρών. Η Σωματοστατίνη (όπως και η **Οκτρεοτίδη**: αρχικώς σε *iv-bolus* 50-100 μ g και εν συνεχεία σε στάγδην έγχυση 50 μ g/h) δρουν ανασταλτικά στην κινητικότητα και την έκκριση ορμονών του γαστρεντερικού, όπως της γαστρίνης, της χολοκυστοκίνης και της έκκρισης γαστρικού οξέος.
10. Σε περίπτωση που η αιμορραγία συνεχίζεται (και πιθανώς οφείλεται σε ηπατικό νόσημα κιρσορραγία ή οισοφαγο-γαστρικό νεόπλασμα) χορηγούμε 1 gr **Τρανεξαμικό οξύ** (TXA), ήτοι 2 amp. Transamin 500 mg σε ορό 500 ml NaCl 0,9%, σε διάρκεια 30-60 λεπτών. (Ασκήν αντνωδολυτική δράση στους ιστούς για διπλάσιο χρόνο από ό,τι στο πλάσμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με καρδιακή, νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. Η ταχεία ενδοφλέβια έγχυση μπορεί να προκαλέσει βραδυκαρδία, υπόταση και αρρυθμίες).
11. Τοποθετούμε ουροκαθετήρα Foley 14-16 fr, για τον υπολογισμό του ισοζυγίου υγρών.
12. Επί ανησυχίας ή διέγερσης του ασθενούς, επιχειρείται ήπια καταστολή, με τη χορήγηση 1 amp. των 10 mg Διαζεπάμης (Stedon) σε 100 ml NaCl 0,9% σε αργή (iv) έγχυση.
13. Διακομιδή στο νοσοκομείο, άμεσα, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχές monitoring (HKT, AΠ, HR, RR, SpO₂), αφού επικοινωνήσουμε με το ΤΕΠ και ενημερωθεί η Γαστρ/γική κλινική και η Αιμοδοσία. Η **επείγουσα ενδοσκόπηση** του ανωτέρου πεπτικού συστήματος είναι η εξέταση εκλογής που πρέπει να γίνεται σε ασθενείς με αιματέμεση ή μέλαινα κένωση.
14. Εάν ο ασθενής προσέρχεται μόνο με αναφερόμενη αιμορραγία του ανωτέρου πεπτικού (αιματέμεση και όχι μέλαινα) και σύμφωνα με την **κλίμακα Glasgow - Blatchford** έχει συνολική βαθμολογία μηδέν (0), στις κάτωθι κλινικο-εργαστηριακές παραμέτρους:

- | | |
|---|--|
| ■ Αιμοσφαιρίνη (Hb) ≥ 13 g/dl (♂), | ■ Ουρία < 39 mg/dl ή BUN < 6,5 mg/dl. |
| Αιμοσφαιρίνη (Hb) ≥ 12 g/dl (♀). | ■ Όχι μέλαινα ή συγκοπτικό επεισόδιο. |
| ■ ΣΑΠ (SBP) > 109 mm Hg. | ■ Όχι ιστορικό ή παρούσα ηπατική νόσο. |
| ■ Σφύξεις (HR) < 100 bpm. | ■ Όχι ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας. |

τότε μπορεί να παραμείνει για λίγες ώρες υπό παρακολούθηση στο ιατρείο, στο ΤΕΠ ή στη MBN και εν συνεχεία να αποδεσμευτεί για την οικία του με σαφείς γραπτές οδηγίες.

❖* Οι κιρσοί του οισοφάγου, που παρουσιάζονται σε κιρρωτικούς ασθενείς, αποτελώντας τη σοβαρότερη επιπλοκή της πυλαίας υπέρτασης, αιμορραγούν σε ποσοστό περίπου 30%. Και από αυτούς δε τους ασθενείς περίπου το 30% θα πεθάνει κατά την πρώτη νοσηλεία!

Σε αιμορραγία κιρσών οισοφάγου, η αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση παραμένει η ίδια, με τη διαφορά ότι **αποφεύγουμε να τοποθετήσουμε σωλήνα Levin**, αλλά τοποθετούμε προσωρινά (για 6-12 ώρες) – εφόσον έχουμε πείρα – **καθετήρα Sengstaken - Blakemore**.

Ο ειδικός καθετήρας Sengstaken - Blakemore έχει μήκος 85 εκ. και φέρει 2 αεροθάλαμους. Ο 1^{ος} αεροθάλαμος τίθεται εντός του στομάχου και πληρούται με 125 ml ορό (max: 300 ml). Ο 2^{ος} αεροθάλαμος βρίσκεται εντός του οισοφάγου και πληρούται με 40 ml αέρα (αν και σήμερα υπάρχει η τάση αυτός ο αεροθάλαμος να μην φουσκώνεται για αποφυγή επιπλοκών). Η αρχική φαρμακευτική αγωγή στο ΤΕΠ περιλαμβάνει τη χορήγηση αγγειοσυσπαστικών Βαζοπρεσίνης (Pitressin) ή Σωματοστατίνης (Stilamin) ή Οκτρεοτίδιου (Sandostatin).